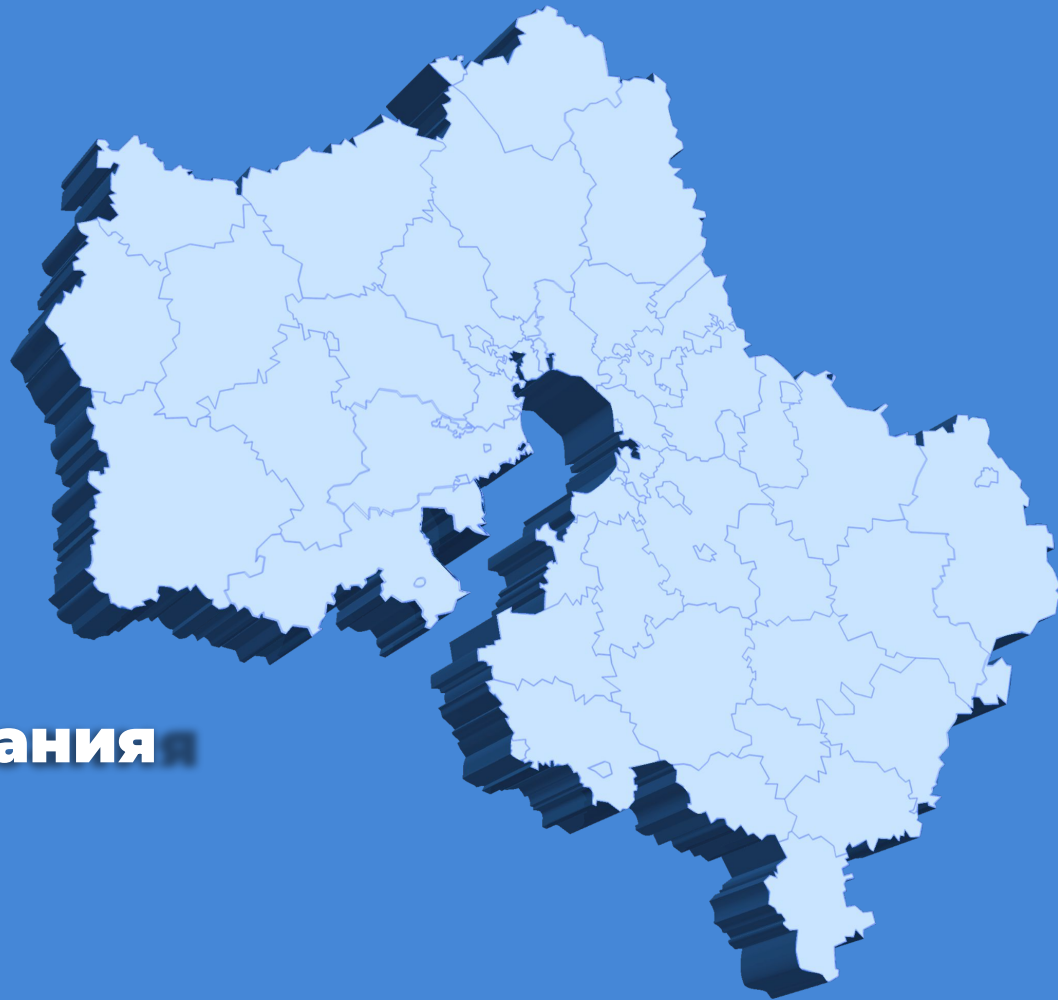




МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Эффективное планирование расписания на примере опыта Московской области



ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ РАСПИСАНИЯ В МЕД. ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ЖАЛОБЫ

ЗА 2025 Г.

- Жалоб на доступность записи к врачу - 29,9 тыс (30% от всего обращений на ПМСП)
- Жалобы на медицинские документы пациента - 47 тыс.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

1. Нерациональное использование кадров
2. Отсутствие контроля расписания на уровне руководящего состава ЛПУ

ПОСРЕДСТВОМ МИС ВЫЯВЛЯЮТСЯ:

1

Неоформленные после приема пациентов мед. документы (20 тыс. ежегодно в поликлиническом подразделении)

2

Множественные посещения одних и тех же пациентов к одному врачу (5 тыс. ежегодно в поликлиническом подразделении)

3

“Сгорание” слотов из-за неявок и ошибок нормирования расписания (150 тыс. ежегодно в поликлиническом подразделении)

4

Ненормативная загрузка подразделений мед. организации (52% средняя загрузка подразделений)



ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЫЛ СФОРМИРОВАН ПРОЕКТ “ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСПИСАНИЯ”



ЦЕЛЬ -

поднять уровень удовлетворенности при обращении в амбулаторно-поликлинические учреждения Московской области к **25.12.2026**

Запаздывающий показатель

1. Доступность записи

(среднее время ожидания в днях) - основной показатель эффективности системы расписания

Участковая служба: не более **1 дня**

Узкие специалисты: не более **10 дней**

2. Сокращение количества жалоб в категориях:

“Запись на прием к врачу” - **на 30%**

“Медицинские документы пациента” - **на 15%**

Опережающий показатель

1. Процент «сгоревших» ячеек - снижение до **5%** за счет автоматического перераспределения и контроля.
2. Процент неявок от записанных пациентов - снижение до **1%** за счет проактивного оповещения пациентов
3. Контроль горизонта создания расписания в мед. организациях - **21 день**



ОШИБКИ ВЕДЕНИЯ РАСПИСАНИЯ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

- 1** Ежегодно создается 150 тыс. (30% расписания) невостребованных слотов.
- 2** Ежегодно 20 тыс. (4%) незакрытых ТАП и 5 тыс. (1%) сверхнормативных посещений в поликлиническом подразделении.
- 3** Ежегодные потери слотов в расписании:
 - 30 тыс. слотов (6%) — из-за неявок.
 - 10 тыс. слотов (2%) — из-за нарушения нормативов создания ячеек на занимаемую ставку

МЕРОПРИЯТИЯ

1. Внедрение единого регламента (Приказ) с типовым набором слотов
2. Контроль конкурентных слотов по каждому врачу (Дашборд)

1. Контроль наличия и срока действия ЭЦП.
2. Контроль активности учетных записей главных врачей в ЕМИАС
3. Мониторинг своевременного закрытия ТАП (у специалистов с действующей ЭЦП)
4. Контроль сверхнормативных посещений

Доработки МИС:

1. Адаптивные шаблоны расписания с нормативным количеством слотов записи для всех специалистов, внедренные в ЕМИАС
2. Автоперевод невостребованных неконкурентных ячеек в самозапись в 19:00 предыдущего дня
3. Запрет на формирование неконкурентных ячеек в начале и конце смены для сокращения времени приема.



ПИЛОТИРОВАНИЕ РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ ГБУЗ МО “БАЛАШИХИНСКАЯ Б”

В МЕД. ОРГАНИЗАЦИИ ОБНАРУЖЕНО 4/4 КЛЮЧЕВЫХ ОШИБОК ВЕДЕНИЯ РАСПИСАНИЯ

1. Неэффективное использование ресурса кабинетов
2. Неравномерная загрузка специалистов в подразделениях
3. Незакрытые ТАП и сверхнормативные посещения
4. Потери расписания от неявок и нарушений нормативов создания ячеек



ЗАГРУЗКА МЕД. ОРГАНИЗАЦИИ:

До пилотирования - 45%

Во время пилотирования - 55%

ОБЩАЯ ЗАГРУЗКА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЛУЧШИЛАСЬ НА 10%

	БЫЛО НА 22.01.2026	СТАЛО НА 08.02.2026
Доступность по участковой службе	1,98 дн.	1,33 дн.
Педиатрия	1,55 дн.	1,81 дн.
Терапия	2,43 дн.	0,79 дн.
Доступность по узким специалистам	6,05 дн.	4,25 дн.

СРЕДНЯЯ ДОСТУПНОСТЬ УЛУЧШИЛАСЬ НА 2,5 ДН. (30%)



РАСПИСАНИЕ: РАЗБОР УЧАСТКОВОЙ СЛУЖБЫ

ГБУЗ МО «БАЛАШИХИНСКАЯ Б» ПОЛИКЛИНИКА № 12

№ п/п	Врачи	Ставки	План на неделю	Всего создано	% выполнения норматива	Всего занято	Доля занятых от созданных
	1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/4
	Итого	15,5	3021	2 518	81%	1 780	66%
1	Багандова С.И.	1	195	177	91%	174	98%
2	Гулиева А.Г.	1	195	176	90%	173	98%
3	Ковалев Ю.Е.	1	195	192	98%	188	98%
4	Степанова М.В.	1	195	151	77%	147	97%
5	Гаджиева И.Б.	1	195	146	74%	140	96%
6	Каирова А.К.	1	195	189	75%	180	95%
7	Петросян В.Э.	0,25	48	32	66%	17	53%
8	Нуцулханова Д.Ш.	1	195	160	82%	83	52%
9	Хизроева П.Г.	1	195	69	35%	35	51%
10	Толиббекова З.А.	1	195	160	82%	48	30%
11	Джамбаев Р.А.	1	195	209	107%	40	19%
12	Баркова Т.В.	1	195	237	122%	193	81%
13	Седнева Е.М.	1,25	243	211	87%	152	72%
14	Сенотова Т.Б.	1	195	189	97%	112	59%
15	Магомедова А.М.	1	195	100	51%	45	45%
16	Маракулина Т.Н.	1	195	120	62%	53	44%

СОГЛАСНО ПРОВЕДЕННОМУ АНАЛИЗУ:

- у 8 врачей занятость расписания составляет менее 60%.

- 10 врачей не выполняют норматив по приему пациентов, установленный для их ставки.

- Каждый третий созданный талон остается невостребованным, в то время как пациенты жалуются на отсутствие записей

РЕШЕНИЯ

1. Увеличение самозаписи **на 5%**
2. Увеличение создаваемых ячеек в участковой службе согласно занимаемой ставке **на 15%**
3. Увеличение создаваемых ячеек за счет стандартизации времени приема **на 5%**

ЭФФЕКТЫ

>550

конкурентных слотов будет создано дополнительно на еженедельной основе



ПОЛУЧЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ

1. Улучшение доступности в мед. организациях, где проводился пилот:

- участковой службы **на 0,5 дн.**
- узких специалистов **на 1 дн.**

2. Повышение загрузки мед. организации **на 10%**

Раннее выявление и адресная работа с проблемными МО, что привело к:

- ### 3. Снижению жалоб на мед. документы **на 5%**
- ### 4. Снижению жалоб на доступность записи к врачам **на 30%**